

RICARDO AKIO IAMAMOTO	
HD:	
MEDICO:	Drª Priscila
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	29 cm
PA:	20 mmHg - 10 mmHg - 10 mmHg
OXIMETRIA:	IAH = 30,5
01/07 Adaptação do CPAP - másc. nasal	
21 P = 5 - 15 cmH ₂ O	
08/07 P = 9.3	
21	IAH = 1.4
m. de uso: 6hs — <i>boa</i>	
03/08 P = 9.8	
21	IAH = 1.3
m. de uso: 4h 48' — <i>boa</i>	
24/08 P = 8.7 cmH ₂ O	
21	IAH = 1.5 lv
m. de uso: 4h 30'	
sem queixas — <i>boa</i>	
14/09 P = 8.8 cmH ₂ O	
21	IAH = 1.5
m. de uso: 5h 14' — <i>boa</i>	
09/11 P = 8.7 cmH ₂ O	
21	IAH = 1.0
m. de uso: 6hs	
Bem adaptado, sem queixas — <i>boa</i>	
03/12 IAH = 0.4	
22	P = 8.6
m. de uso 4h 30' — <i>boa</i>	
23/08 m. de uso: 5h 12'	
22	P = 8.3 cmH ₂ O
m. de uso: 0.3 lv	

08/11
22

$P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.6 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h
Bojo ressecado.

ajusto a máscara

— Jua

17/01
23

$P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 4h50'
Bem adaptado

— Jua

22/03
23

$P = 7.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 5h
 $IAH = 0.2 \text{ e/ev}$
Bem adaptado

fuga = 21.8 l/min

Jua.

24/05
23

$P = 7.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.6 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h30'
Bem adaptado

fuga = 9.3 l/min

↓ a pressão 5 - 7 cmH_2O
Acho Jua.

31/08
23

$P = 7.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.3 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h
Fuga = 18.

Jua

07/11
23

$P = 5-7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h
Fuga = 23.3 l/min

troco máscara.

Jua.

23/01
24.

$P = 5-7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1.6 \text{ e/ev}$
m. de uso: 4h34'

Relata dor de cabeça, q-
n utiliza o CPAP (Jua

17/04
24

$P = 6.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso:
 $IAH = 0.3 \text{ e/ev}$
Fuga = 13.6 lpm.

melhora da dor de
cabeça.

Jua

17/04
24

$P = 6.1 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1.2$
m. de uso: 5h
Fuga = 1.3 lpm.

Jua

30/10 P = 5,9
24 IAH = 0,7 e/h
m. de uso: 4h20'

Querva de escape de ar e
instabilidade do prong e
uso acordo. *lua*

07/04 P = 6,2 cm/H₂O
25 IAH = 0,5 e/h
m. de uso: 5h13'
fuga = 0,1 e/h

lua

07/07/25 P = 6,0 cm H₂O
IAH = 0,7 e/h
m. de uso: 5h15'
fuga: 9,6 e/m

Bem adaptado cl maxava
cl prong raxal

Natasha

Nome: RICARDO AKIO IAMAMOTO

Data de Nascimento: 22-4-1959

IMC: 32,51

Sexo: Masculino

Data do exame: 22-12-2018

Peso: 103 kg

Altura: 1,78 m

Médico: DRA. PRISCILA L. SILVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 22-12-2018, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 419,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 3,5 e 133,0 minutos. O tempo total de sono foi de 350,5, eficiência de 83,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 52,9%; estágio N3: 24,3%; sono REM: 20,5%. O índice de despertares foi de 17,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 30,5, sendo elas 123 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 55 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 78%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 61 - 80 bpm e NREM de 61 - 83 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 30,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=78%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

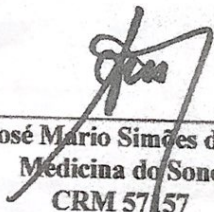
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Ricardo Akio Iamamoto

À EMPRESA DE ADAPTAÇÃO DE CPAP

PACIENTE COM RONCOS E APNÉIA, SEM MELHORA COM TRATAMENTO CLÍNICO.

POLISSONO

EFICIÊNCIA DO SONO - 83,7%

IAH - 30,5/H

SAT - 91%

NADIR- 78%

SOLICITO ADAPTAÇÃO PARA CPAP, COM MÁSCARA ORONASAL, EM RAMPA, AUTOMÁTICO, COM CARTÃO DE LEITURA

CID: G47.3

Luiz Antonio da Silveira
Médico
CRM - 40.263 - RQE: 38744

Dra. Marina Leite da Silveira
Dermatologista
CRM 130.637 / RQE: 36404

Dr. Mateus Francisco S. Libardi
Ortopedia e Traumatologia
Especialista em Joelho
CRM - 143.110 / TEOT: 13337
RQE: 49194

Dra. Priscila Leite da Silveira
Otorrinolaringologista
CRM - 140.497 / RQE: 40311

Dra. Priscila L. Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140.497